

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Patient Copy Gastrectomy

معلومات الإقرار – نسخة المريض استئصال المعدة

1. What is gastrectomy?

A gastrectomy is the removal of part or all of the stomach. The end of the food pipe (oesophagus) will be stitched to the remaining part of the stomach or duodenum.

2. My anaesthetic?

This procedure will require an anaesthetic. See About Your Anaesthetic information sheet for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.

1. ما هو استئصال المعدة ؟

استئصال المعدة هو إزالة كامل المعدة أو جزء منها . تتم خياطة نهاية المريء بالجزء المتبقي من المعدة أو بالإثنى عشر.

2. التخدير الذي أتلقاه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير. اقرأ ورقة معلومات التخدير المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات ، قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد يحدث التهاب، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار داياباير دامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
- قد ينتج عن إجهاد القلب وحدث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- قد يحدث انسداد لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications and thrombosis.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Especially in a male there may be difficulty passing urine and a tube may need to be inserted into the bladder, until the bladder is able to empty normally.
- Deep bleeding in the abdominal cavity could occur and this may need fluid replacement or further surgery.
- Breakdown of the bowel anastomosis which causes leakage of stomach and duodenal secretions with very severe problems of infection. This can be life threatening.
- Damage of the bowel may occur which may cause leakage of bowel fluid. This may need further surgery.
- Infections such as pus collections can occur in the abdominal cavity. This may need surgical drainage.
- The bowel movement may be paralysed or blocked after surgery and this may cause building up of fluid in the bowel with bloating of the abdomen and vomiting. Further treatment may be necessary for this.
- A weakness can occur in the wound with complete or incomplete, bursting of the wound in the short term, or a hernia in the long term. This may need further surgery.
- Some people develop a problem called "dumping". This causes a dizzy feeling and near-faints 1-2 hours after meals.
- Nutritional problems after the surgery e.g. anorexia, low iron, loss of weight and recurrent bilious vomiting.
- The wound may become thickened and red and

- عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المفرطة ، تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الجرح أو الصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- عند الذكور بصورة خاصة ، قد تكون هناك صعوبة في إدرار البول، مما قد يتطلب وضع أنبوب (قسطرة بولية) في المثانة إلى أن تعود المثانة للإفراغ الطبيعي للبول.
- نزيف عميق في التجويف البطني قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.
- تهتك منطقة المفاغرة (التفم) المعوية وهي المنطقة التي تمت فيها خياطة أجزاء الجهاز الهضمي مع بعضها البعض بعد استئصال المعدة ، مما يسبب تسرب إفرازات المعدة والإثني عشر وحدوث عدوى شديدة. قد يكون ذلك مهدداً لحياة المريض.
- ضرر يصيب الأمعاء مسبباً تسرب لسوائل الأمعاء ، مما قد يتطلب جراحة أخرى .
- الإصابة بعدوى كتجمعات للصدید في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصدید جراحياً .
- قد تصاب حركة الأمعاء بالانسداد أو الكسل بعد العملية مما يسبب تراكم السوائل في الأمعاء وانتفاخ للبطن وتقيؤ. قد يتطلب الأمر علاج آخر.
- ضعف قد يعتري الشق الجراحي ويؤدي على المدى القريب إلى تمزقه بشكل جزئي أو كامل ، وعلى المدى البعيد قد يتسبب ذلك في نشوء فتق. قد يتطلب ذلك جراحة.
- بعض المرضى يصابون بما يعرف بـ "الإغراق" وهو الانتقال السريع للطعام الذي لم يهضم بشكل كاف من المريء إلى الأمعاء بسبب استئصال المعدة . يسبب ذلك الشعور بالدوخة وما يشبه الإغماء بعد 1-2 ساعة من تناول الطعام.
- حدوث مشاكل متعلقة بالتغذية مثل فقدان الشهية ، انخفاض مستوى الحديد ، فقدان الوزن والتقيؤ المتكرر للمادة الصفراء.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

may be painful.

- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short term or a long-term complication and may need further surgery.
- The ulcer or tumour may recur.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

Notes to talk to my doctor about:

- قد يصبح الجرح سميكاً وأحمر اللون وقد يكون مؤلماً.
- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.

- قد يعود التقرّح أو الورم. للظهور مرة أخرى.
- عند المدخنين تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي :
